Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
1ª Vara Cível da Comarca de Santa Maria

Rua Alameda Buenos Aires, 201 - Bairro: Nossa Senhora das Dores - CEP: 97050545 - Fone: (55) 3222-8888 - Email: frsantmari1vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5012470-32.2023.8.21.0027/RS

AUTOR: CELIA ABIGAIL CESAR

RÉU: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - IPERGS

SENTENÇA

Vistos e examinados os autos.

CELIA ABIGAIL CEZAR, já qualificada, ajuizou ***Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência*** em face do **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRADE DO SUL,** também qualificado, alegando que conta com 73 anos de idade e apresenta Neoplasia do Endométrio (CID C 54.9). Afirmou que foi prescrito o medicamento KEYTRUDA, (Pembrolizumabe) para o tratamento. Sustentou que não possui condições de custear o tratamento, tendo em vista o seu alto custo. Mencionou ter solicitado o farmáco ao plano de saúde réu, mas foi indeferido. Discorreu sobre a legitimidade passiva "ad causam" e sobre o direito à saúde. Pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar que o réu forneça o medicamento, KEYTRUDA, (Pembrolizumabe). Requereu a procedência do pedido para condenar o réu a fornecer em definitivo o fármaco. Vindicou a concessão da gratuidade judiciária. Anexou documentos (evento 1).

Recebida a petição inicial, foi deferida a gratuidade judiciária (evento 5, DESPADEC1) e concedida a tutela de urgência pleiteada (evento 24, DESPADEC1).

Citado, o Ipê-saúde - Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul, apresentou contestação (evento 12, CONT1), pontuando que a pretensão autoral é ilegal, uma vez que, pretende o custeio de tratamento não previsto pela Autarquia. Mencionou que o Ipê-saúde é entidade pública estadual, estando sujeito a normas específicas. Dissertou que a Autarquia tem sua cobertura definida pela Lei Complementar n° 15.145/2018. Defendeu que diferentemente dos Planos de Saúde privados que possuem contratos com seus beneficiários e necessitam de cláusula contratual expressa para a negativa de cobertura, o IPE-Saúde é instituído por Lei e administrado por uma Autarquia estadual, o que determina a observação integral dos princípios aplicáveis à Administração Pública. Discorreu sobre a alternativa de tratamento de câncer de útero dentro da cobertura do Ipê-Saúde e sobre a sustentabilidade do Fundo de Assistência à Saúde-FAS. Requereu a improcedência da ação.

Houve réplica (evento 35, RÉPLICA1).

As partes não manifestaram interesse na produção de outras provas (evento 41, PET1 e evento 42).

O Ministério Público apresentou parecer, opinando pela procedência do pedido (evento 45, PROMOÇÃO1).

Vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Passo a decidir.

Trata-se de Ação de Obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por Celia Abigail Cezar em face do Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul, objetivando a condenação do réu ao fornecimento do forneça do medicamento, KEYTRUDA, (Pembrolizumabe).

Não havendo preliminares e nem prejudiciais de mérito a serem analisadas, passo ao exame do mérito.

A parte autora afirma na petição inicial ser portadora de Neoplasia do Endométrio (CID C 54.9). e portanto, necessita do fornecimento do medicamento KEYTRUDA, (Pembrolizumabe). Sustentou que não possui condições financeiras de custear o tratamento, tendo em vista o alto custo do farmáco.

O IPE-SAÚDE arguiu que o tratamento postulado não se encontra coberto pelo plano, bem como não estão previstos no Protocolo Oncológico do Instituto.

Inicialmente, cabe salientar que o artigo 4º da Lei Complementar nº 15.145/2018, que dispõe sobre o IPÊ-Saúde, refere que integram o plano de saúde atendimento médico, hospitalar, atos necessários ao diagnóstico e ao tratamento, assim como ações de prevenção da doença e promoção à saúde: (…) Artigo 4º- O Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Rio Grande do Sul – Sistema IPE Saúde – consiste na cobertura das despesas decorrentes dos procedimentos previstos em tabelas próprias do Instituto para atendimento médico, hospitalar, ambulatorial, laboratorial, bem como dos atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários, na forma estabelecida nesta Lei Complementar e em resoluções do Órgão Gestor. (…)

Todavia, o parágrafo único do artigo 4º da citada Lei Complementar restringe o fornecimento de tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais aos que estejam previsto nas tabelas do Instituto.

Insta frisar que, malgrado exista a previsão de exclusão na legislação de regência, somente justifica-se sua incidência quando não comprovada a necessidade do fornecimento dos tratamentos, exames, procedimentos, insumos e materiais para o tratamento da patologia, conforme entendimento sedimentado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PÚBLICA. IPÊ- **SAÚDE**. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA O TRATAMENTO DE CÂNCER JAKAVI® (RUXOLITINIBE). PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. **A circunstância de não existir previsão de cobertura no regulamento do IPERGS não é motivo suficiente para o indeferimento do pedido. Conforme dispõe o art. 4º da Lei Complementar 15.145/08, integram o Plano IPE-SAÚDE os atendimentos médicos, hospitalares, ambulatoriais, laboratoriais, bem como atos necessários ao diagnóstico e aos tratamentos devidos aos usuários.** Em que pese as disposições do parágrafo primeiro do artigo supramencionado, tem-se que a ausência de previsão no Protocolo Oncológico não deve servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento médico postulado, notadamente porque as Recomendações são de 2010, logo desarrazoado negar acesso do segurado a tratamento médico quando evidente a ausência de atualização do Protocolo e suas Recomendações em Oncologia. Hipótese dos autos em que se encontram presentes os requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da antecipação de tutela requerida, uma vez que restou comprovada a necessidade e a urgência do medicamento solicitado, através de laudo médico especializado, razão pela qual imperiosa a manutenção da tutela provisória de urgência concedida na origem. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70079951091, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"APELAÇÃO CÍVEL. IPÊ-SAÚDE. LINFOMA NÃO-HODGKIN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. IBRUTINIBE. NEGATIVA DO IPERGS. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. **I. A Lei nº 12.134/2004, que reestruturou o IPERGS, dispõe que o Sistema de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul, seus dependentes e pensionistas, engloba um conjunto de ações visando à prevenção de doenças, à promoção, educação e assistência à saúde de seus usuários (arts. 1º e 2º). II. Em que pese a edição da Lei Complementar nº 15.145/2018, que altera a Lei Complementar nº 12.066/2004, disciplinando que descabe a imposição ao IPERGS de medicamentos não previstos em seus regramentos, entendo que a falta de previsão nos protocolos ou listas da autarquia previdenciária e o alto custo do medicamento não devem servir de obstáculo ao fornecimento do tratamento postulado, visto que demonstrada a necessidade do uso do fármaco, bem como a condição de segurado da autarquia**. III. Honorários advocatícios reduzidos. Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70080627953, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Aurélio Heinz, Julgado em 27/03/2019)"[grifo nosso]*

Ademais, cumpre esclarecer que o Superior Tribunal de Justiça vem firmando entendimento de que não cabe ao plano de saúde selecionar o tratamento que será dispensado ao segurado para a patologia coberta pelo plano, como ilustram as seguintes ementas de julgados proferidos pelo Tribunal da Cidadania:

> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE **SAÚDE**. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. **3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo.** 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*
>
> *"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE **SAÚDE**. EXCLUSÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO MÉDICO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de obrigação de fazer combinada com indenização por danos materiais e compensação por danos morais. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. **3. O plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para sua realização de acordo com o proposto pelo médico. O fato do procedimento não constar do rol da ANS não afasta o dever de cobertura do plano de saúde, tendo em vista que se trata de rol meramente exemplificativo**. 4. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no recurso especial desprovido. (AgInt no AREsp 1345913/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/02/2019, DJe 27/02/2019)" [grifo nosso]*

Dessa forma, extrai-se dever do IPE-SAÚDE em fornecer o tratamento postulado pela parte autora mesmo que este não esteja coberto pelo plano ou que não esteja previsto no Protocolo Oncológico do Instituto, desde que comprovada sua necessidade.

Na hipótese dos autos, a autora acostou laudo médico (evento 1, ATESTMED6) que comprova que a demandante é portadora da patologia denominada Neoplasia do Endométrio (CID C 54.9), bem como necessita do fornecimento do medicamento KEYTRUDA, (Pembrolizumabe), senão vejamos: " *(...) Paciente Celia Abigail Cesar, 73 anos, RG 7024166774, CPF 19512040000, procedente de Santa Maria, tem diagnóstico de neoplasia de endométrio sendo submetida a oan-histerectomia em 18.10.2022 com laudo anátomo-patológico co adenocarcinoma G2 da Figo presente em endométrio, ovários direito e esquerdo e trompa esquerda. (...). Realizada pesquisa de instabilidade microssatélite que confirmou perfil instável. Por tal motivo, solicito a medicação pembrolizumabe 200mg EV a cada 21 dias, incialmente por 6 ciclos (5 meses) com possibilidade de prorrogar por até 35 ciclos (2 anos) caso boa tolerância e resposta. A indicação se baseia no estudo Kaynote 158 (J Clin Oncol. 2022 Mar. 1,40 (7): 752-761). Tal estudo demonstrou taxas de respostas objetiva de 48% sobrevida livre da progressão de 13.1 neses de sobrevida global não alcançadas até pubicação do referido estido. Atualmentem este é o tratamento pedrão ourto para o caso em questão. O referido tratamento está aprovado pela ANVISA, incorporadi pelo Rol da ANS e por tal motovo o solicito. A impossibilidade de prescrevê-lo incorrerá em maior risco de progressão e morte da paciente. A paciente necessita do tratamento com urgência visto que a sua doença está em progressão. (...)"*

Portanto, diante do relatório médico juntado (evento 1, ATESTMED6) pela autora aliado às informações mencionadas, resta demonstrada a necessidade da autora em utilizar do farmáco indicado na inicial para o tratamento de sua patologia.

Registro que a condição da autora como segurada do plano de saúde foi demonstrada pelo documento do evento 1, OUT4 .

Consigno que mesmo demonstrada a necessidade do tratamento pela parte autora, restou indeferida na esfera administrativa a realização do procedimento cirúrgico postulado na exordial (evento 1, OUT7).

No entanto, como já exposto, embora não previsto *"nas recomendações técnicas de oncologia do IPÊ-RS",* tal circunstância não é suficiente para elidir a responsabilidade da Autarquia ré em fornecer o tratamento adequado para a patologia da demandante.

Em síntese, comprovada a necessidade do tratamento pela parte autora, bem como a responsabilidade em fornecê-lo pela Autarquia ré, impõe-se a procedência do pedido vertido na peça vestibular.

Dispositivo.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil de 2015, **JULGO PROCEDENTE** o pedido formulado por **CELIA ABIGAIL CESAR** em face do **INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO RIO GRANDE DO SUL - IPÊ-SAÚDE** para o fim de confirmar a tutela de urgência deferida, tornando-a definitiva e condenar a parte ré para que custeie o medicamento KEYTRUDA, (Pembrolizumabe).

Retifique-se o polo passivo para constar o Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado do Rio Grande do Sul - IPÊ-SAÚDE.

Isento o Instituto de Assistência à saúde dos Servidores Público do Rio Grande do Sul-IPÉ Saúde ao pagamento da Taxa Única.

Condeno a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora, os quais fixo em R$ 600,00, nos termos do §8° do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015.

Havendo apelação, considerando as novas disposições do Novo Código de Processo Civil (art. 1.010), que determina a remessa do recurso independentemente de juízo de admissibilidade no primeiro grau, deverá o Cartório intimar a parte recorrida para oferecer contrarrazões e dar vista ao Ministério Público para parecer, se for o caso, e, na sequência, remeter os autos à instância superior.

Tratando-se de sentença ilíquida proferida contra a Fazenda Pública, deve ser submetida ao reexame necessário, consoante entendimento cristalizado na Súmula nº 490 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, com ou sem recurso voluntário, remetam-se os autos ao Colendo Tribunal de Justiça para reexame.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-se.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Documento assinado eletronicamente por **DIEGO TEIXEIRA DELABARY, Juiz de Direito**, em 17/7/2024, às 16:16:42, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10051109638v5** e o código CRC **48fbcda8**.